“PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPOS Y RECURSO HUMANO PARA IMPLEMENTACIÓN PERMANENTE DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA HSC”

CÓDIGO BIP: 40059567-0

HOSPITAL DE SAN CARLOS
DR. BENICIO ARZOLA MEDINA

FEBRERO 2026

1.- INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han producido cambios importantes en el perfil epidemiológico evidenciado en el aumento de la esperanza de vida con el correspondiente envejecimiento poblacional, aumento de la prevalencia de patologías crónicas, pandemia Covid-19, entre otros; lo que conlleva un incremento de la demanda de atención en salud. Este aumento significativo de la demanda hace que el recurso cama sea necesario lo que nos obliga a crear estrategias para suplir esta necesidad y dar respuesta satisfactoria a las distintas necesidades de nuestros usuarios. Una de estas es la Hospitalización Domiciliaria (HODOM).

La HODOM es una estrategia asistencial alternativa a la hospitalización tradicional, en donde el usuario recibe cuidados similares a los otorgados en los establecimientos hospitalarios, tanto en calidad como en cantidad, en atención a lo exigido por su estado de salud para su manejo clínico y terapéutico, y sin los cuales habría sido necesaria su permanencia en el establecimiento de atención cerrada.

Esta estrategia se ha implementado en nuestro Hospital en 3 oportunidades los últimos años en el contexto de campaña de invierno, sólo por un periodo acotado. Durante los meses de funcionamiento ha resultado fundamental para la mejora del proceso de hospitalización, en especial frente a la demanda creciente de pacientes en espera de cama de dotación en la Unidad de Emergencia. Además, nos ha permitido destinar recurso cama hospitalaria a otro paciente de mayor riesgo cuyo tratamiento es más complejo y que no es posible realizar en domicilio para asegurar una evolución favorable según condición clínica de cada paciente. Por otro lado, nos ha sido posible entregar cuidados integrales por un equipo multidisciplinario con una atención humanizada e incorporando a la familia lo que favorece la pronta recuperación del paciente y su reinserción en su medio familiar y social.

Durante la permanencia del paciente en esta modalidad de hospitalización, se realizan las coordinaciones necesarias para lograr la continuidad de la atención con el nivel primario y secundario según corresponda; de esta manera, la hospitalización domiciliaria se constituye como una interfaz entre los niveles asistenciales de mayor complejidad y el nivel primario.

2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

2.1.- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.

Durante la última década hospitalaria se ha observado un incremento sostenido en la demanda de atenciones y consultas de usuarios de distintos grupos etarios en las Unidades de Emergencia de la comuna. Este aumento ha derivado en un mayor requerimiento de hospitalizaciones, asociado a la diversidad y complejidad de las patologías que afectan tanto a la población comunal como provincial.

Dicha situación ha impactado negativamente en los indicadores de oportunidad de hospitalización, generando retrasos en el acceso a camas y en el inicio oportuno de procedimientos y tratamientos. Lo anterior se ve agravado por la brecha existente entre la disponibilidad de camas hospitalarias y el número de habitantes de la región, lo que produce inequidades en el acceso a una atención hospitalaria oportuna y de calidad, con el consiguiente aumento de la insatisfacción usuaria.

En este contexto, y gracias a los fondos asignados a través de campañas del Ministerio de Salud (MINSAL), se ha iniciado la estrategia de Hospitalización Domiciliaria, la cual ha demostrado ser una herramienta efectiva para reducir la presión asistencial y descongestionar el Servicio de Urgencias del Hospital de San Carlos. Esta modalidad ha permitido atender a los usuarios de acuerdo con su complejidad y nivel de cuidados requeridos, priorizando especialmente a la población adulta mayor.

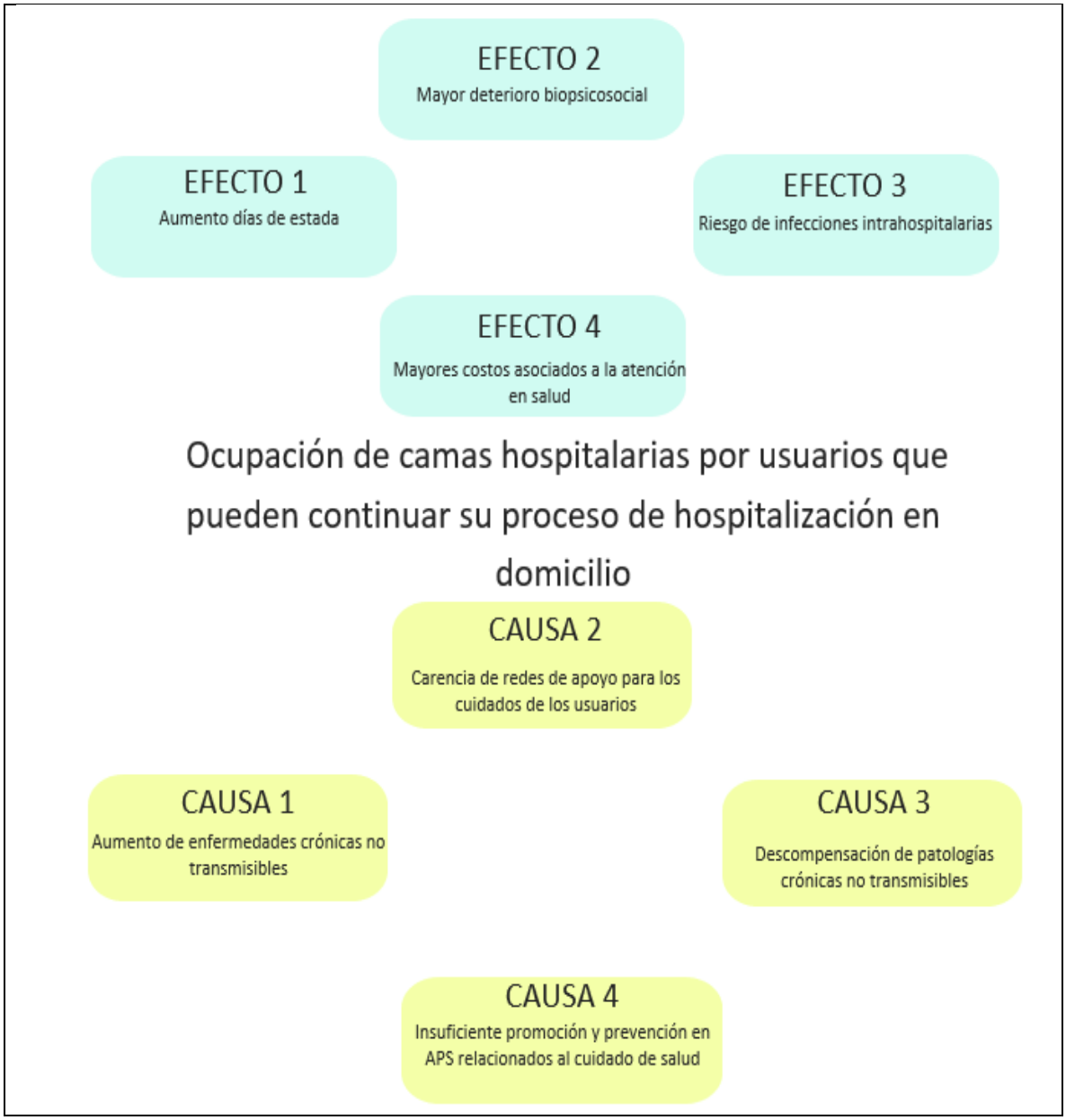
No obstante, se vuelve imperativo consolidar y disponer de manera permanente de la Hospitalización Domiciliaria, con el fin de garantizar a la comunidad de la provincia de Punilla el acceso a un modelo de atención hospitalaria que favorezca la recuperación del estado de salud de las personas y permita resolver de forma oportuna las diversas necesidades de cuidado de la población.

Adicionalmente, debe considerarse la atención de usuarios provenientes de otras regiones y redes asistenciales que consultan directamente en la Unidad de Emergencia del Hospital de San Carlos. Tal es el caso de usuarios de la Región del Maule, particularmente de las comunas de Parral y Talca, quienes acuden de manera espontánea y cuya atención no puede ser rechazada. Asimismo, se registra la demanda de usuarios pertenecientes a la red asistencial de la comuna de Chillán, quienes también consultan directamente en este establecimiento.

Esta situación incrementa aún más la presión sobre la capacidad resolutiva del hospital, reforzando la necesidad de fortalecer estrategias como la Hospitalización Domiciliaria, que permitan optimizar los recursos disponibles y mejorar la oportunidad y calidad de la atención hospitalaria.

Unidad de Proyectos e Inversiones – HSC
aldo.quiroz@redsalud.gov.cl Anexo Red MINSAL: 426260

2.2.- ARBOL DE PROBLEMAS.



Unidad de Proyectos e Inversiones – HSC
aldo.quiroz@redsalud.gov.cl Anexo Red MINSAL: 426260

2.3.-OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.3.1.- OBJETIVO GENERAL:

Implementar en forma permanente la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (HODOM) en el Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola Medina, como un modelo para prestar servicios de salud en el domicilio de los usuarios y usuarias que viven en las comunas de San Carlos, San Nicolás, San Fabián, Ñiquén y los diferentes sectores rurales aledaños, resguardando el cumpliendo de los estándares de calidad que se establecen en la norma Ministerial, favoreciendo el autocuidado y contribuyendo a fortalecer la participación de la familia en el tratamiento y recuperación de los pacientes, permitiendo a la vez, optimizar el recurso cama hospitalaria y contribuir a la contención de costos, mediante la utilización racional de los recursos hospitalario.

2.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Optimizar el recurso cama dentro del establecimiento.
- Estandarizar el proceso de atención de hospitalización en domicilio del Hospital San Carlos.
- Favorecer la calidad de vida y confort asistencial de la persona enferma manteniéndolo en su entorno social y familiar.
- Entregar una atención multidisciplinaria, segura y de calidad en su domicilio.
- Disminuir complicaciones secundarias a la hospitalización prolongada (Infecciones asociadas a atención de salud, Delirium, entre otros).
- Disminuir los días de estada y los costos asociados a la hospitalización tradicional.

3.- DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL DE SAN CARLOS.

El Hospital de San Carlos es el segundo de mayor complejidad en Ñuble, y cuenta en la actualidad con una dotación de 130 camas, distribuidas en servicios clínicos con dotación de camas de carácter indiferenciadas adulto e infantil; entre ellos está el Servicio de Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Cirugía, Medicina, Traumatología, CMI, UCHIP, UTI y UCI. Estos servicios clínicos cuentan con unidades funcionales de cuidados (camas de hospitalización) que dan respuesta a la demanda de salud de la comuna de San Carlos y la Red de Ñuble.

Dotación de Camas Hospital de San Carlos

CODIGOS	UNIDADES FUNCIONALES	DOTACION
401	**AREA MEDICA ADULTO DE CUIDADOS BASICOS**	8
	Medicina indiferenciada	
402	**AREA MEDICA ADULTOS DE CUIDADOS MEDIOS**	42
	Medicina indiferenciada	
403	**AREA MEDICO QUIRURGICO DE CUIDADOS BASICOS**	11
	Cirugía básica	
404	**AREA MEDICO QUIRURGICA DE CUIDADOS MEDIOS**	28
	Cirugía indiferenciada	
405	**AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO**	6
	UCI adulto	
406	**AREA DE CUIDADOS INTERMEDIOS ADULTO**	12
	UTI adulto	
409	**AREA MEDICA QUIRURGICA PEDIATRICA DE CUIDADOS BASICOS**	7
	Pediatría general indiferenciada	
410	**AREA MEDICA QUIRURGICA PEDIATRICA DE CUIDADOS MEDIOS**	3
	Pediatría Cuidados Medios	
413	**AREA NEONATOLOGIA DE CUIDADOS BASICOS**	3
	Neonatología básica	
416	**AREA OBTETRICIA**	10
	Obstetricia	
	TOTAL CAMAS HOSPITAL DE SAN CARLOS	**130**

Resolución Ex. 5H2/N° 17

La superficie que dispone el establecimiento es de 15.370,3 m2; en esta área se encuentra emplazado lo siguiente:

Torre Hospitalaria: En donde se encuentran habilitados los servicios clínicos de Ginecología y Obstetricia, Cirugía, Medicina Agudos, Pediatría, UCI y la Unidad de Tratamientos Intermedios (UTI).

CAE Norte: Consultorio Adosado de Especialidades (CAE), SOME, Servicio de Rehabilitación y anexo Policlínico de Cirugía y Neurología Infantil.

Edificio Antiguo: Servicio Dental, Telemedicina y Unidad de Referencia Cardiológica, Consultorio Adosado de Especialidades (CAE Sur), Servicio de Alimentación y Nutrición, Unidad de Apoyo de Laboratorio, Unidad de Medicina Transfusional, Unidad de Imagenología y Farmacia, Servicio de Traumatología y otras unidades administrativas.

Edificio de Urgencias: Se encuentra la Unidad de Emergencia para la Atención de Morbilidad Adulto, Pediátrica y Materno Infantil; Anestesia y Pabellón Quirúrgico, en donde esta última cuenta con 5 pabellones, de los cuales 2 se encuentran habilitados en forma indiferenciada, para intervenciones de cirugía general programadas y cirugía infantil, 1 para intervenciones quirúrgicas de emergencia y 2 para intervenciones quirúrgicas gineco-obstétricas, estos 2 últimos pabellones se encuentran ubicados en el servicio de Ginecología y Obstetricia.

El recurso humano existente es de 922 funcionarios titulares, a contrata y honorarios.
El Hospital de San Carlos, es el centro de referencia de toda la red norte asignada. Este, forma parte de una Red de Salud Pública Integrada además por consultorios municipales, postas, consultorios de especialidad y otros hospitales; cada uno de estos establecimientos atiende problemas de salud de diferente complejidad. Junto con el Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán, son los centros de salud público de mayor complejidad en la nueva región de Ñuble y forman parte de una red constituida por 21 comunas, La red del Hospital de san Carlos (red norte), la constituyen 10 comunas, estas son; San Carlos, San Fabián, Ñiquén, San Nicolás, Ninhue, Quirihue, Coelemu, Cobquecura, Trehuaco y Ránquil.
En el Hospital de San Carlos se desarrollan distintos procesos asistenciales:
- Atención abierta: En la modalidad de atención abierta, el Hospital cuenta con el Servicio de Pre-emergencia Hospitalaria (SAMU), el Servicio de Urgencia, los policlínicos de especialidades infantiles, adultos y materno, Dental, Kinesiología, Traumatología, Cirugía Mayor Ambulatoria y Endoscopía.
- Atención cerrada: En hospitalización no crítica se encuentran Cirugía, Medicina, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Pensionado. En Hospitalización Semicrítica, se encuentra Medicina Agudos, Unidad Preferencial de Accidente Cerebrovascular (UPAC), la Unidad de Tratamientos Intermedios (UTI) Y LA Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
- Atención de Especialidades: Las especialidades que atiende este hospital son las de Medicina Interna, Cirugía, Neurología infantil, Dermatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Obstetricia y Ginecología, Traumatología, Pediatría, Telemedicina, Kinesiología, Proc. Neumología, Imagenología, Dental, Medicina Transfusional, Psicología, Endoscopía y recientemente Cardiología.

3.1.- DETALLE RED ASISTENCIAL ASIGNADA.

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA			
SERVICIO DE SALUD ÑUBLE			
COMUNA	**CONSULTORIOS**	**POSTAS**	**E.M.R.**
SAN CARLOS	CESFAM SAN CARLOS “JOSE DURAN TRUJILLO”	Torrecillas	Chicalindo
		Monte Banco	El ejemplo
		Ribera Ñuble	Culenco
		Toquihua	
		Arizona	
	CESFAM SAN CARLOS “TERESA BALDECCHI”		
	HOSPITAL SAN CARLOS		

Unidad de Proyectos e Inversiones – HSC
aldo.quiroz@redsalud.gov.cl Anexo Red MINSAL: 426260

SAN FABIÁN	CESFAM SAN FABIAN	El Caracol	Paso Ancho
		Trabuncura	Los Sauces
ÑIQUÉN	CESFAM SAN GREGORIO	CHACAY	
		La Gloria	
		Belén	
		Ñiquén	
		Zemita	
SAN NICOLÁS	CESFAM SAN NICOLÁS	Puente Ñuble	Piedra Lisa
			Bajo el Ala
			Santa Rosa
			Lajuela
			El Manzano
NINHUE	CESFAM NINHUE	El Rincón	Talhuan
		El Sauce	Reloca
			San José
			Copín
QUIRIHUE	CA H. QUIRIHUE	Los Remates	Chanco
			La Quebrada
			Las Delicias
			El Durazno
			Culenco
	DESAMU QUIRIHUE		Los Temos
			San J. de La Raya
COBQUECURA	CESFAM COBQUECURA	Buchupureo	Quilé
		Colmuyao	San José
			Pullay
TREHUACO	CESFAM TREHUACO	Dénecan	Cantero
		M. de Leuque	Tauco
		Boca Itata	
COELEMU	CA H. COELEMU	Ranguelmo	Sta. Filomena
		Guarilihue	Perales
	DESAMU COELEMU	Vegas de Itata	
RANQUIL	CESFAM ÑIPAS	Nueva Aldea	
		S.I. de Palomares	

CECOF Pertenecientes a la Micro Red San Carlos		
CECOSF	**CESFAM al que pertenece**	**Comuna**
Valle Hondo	CESFAM Teresa Baldecchi	San Carlos
Cachapoal	CESFAM José Duran Trujillo	San Carlos

Fuente: Unidad de Proyectos e Inversiones HSC

4.- MARCO LEGAL QUE AVALA EL PROYECTO.

- Decreto 1. Aprueba reglamento de establecimientos que otorgan prestaciones de hospitalización domiciliaria Ministerio de Salud; subsecretaría de salud pública fecha publicación: 26-sep-2022 | fecha promulgación: 05-ene-2022
- Ley Nº 20.584 "Derechos y Deberes de los pacientes" Publicado en el Diario Oficial de 24.04.2012.
- Parte del reglamento orgánico de los Servicios de Salud (Dcto. 140 de 2004, publicado en el Diario Oficial el 21-04-05).
- Garantías Explicitas En Salud Del Régimen General De Garantías En Salud: Decreto N° 44 De 2007; Publicado en el Diario Oficial de 31.01.07.
- Reglamento Del Sistema De Acreditación Para Los Prestadores Institucionales De Salud: DECRETO N° 15 DE 2007. Publicado en el Diario Oficial de 03.07.07.
- Reglamento Decreto Nº 140 del 2004, que establece la estructura organización y funciones de los Servicios de Salud.
- Resolución Exenta N° 876 de 2006, del Ministerio de Salud; Resolución Exenta N° 60 de 2007, del Ministerio de Salud; Guías Clínicas del Ministerio de Salud.

Referencias:

- Orientación Técnica de Hospitalización Domiciliaria. Ministerio de Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión de la Red Asistencial. Abril 2021.
- Resolución exenta N° 1031, del 17 de octubre de 2012 "Aprueba procesos clínicos priorizados de apoyo a la gestión de la red asistencial."
- Protocolo de Hospitalización Domiciliaria Hospital de San Carlos. Marzo 2022.

5.- IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DE INFLUENCIA.

A) <u>El Área de Estudio:</u> Corresponde al área que comprende a toda la Región de Ñuble. Esta se encuentra situada en la zona central de Chile, aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Santiago, Se extiende entre los paralelos 36° 08° y 37° y 18°de latitud sur y desde 71° 00° de longitud Oeste hasta el Océano Pacífico.

<u>Límites</u>:

Norte: VII Región del Maule
Sur: Provincias de Concepción y Bío-Bío
Este: República Argentina
Oeste: Océano Pacífico

Su superficie territorial corresponde a 13.951 KM2. Su población es de 517.060 habitantes.

B) <u>El Área de Influencia</u>: Está comprendida por las 10 comunas asignadas a la red asistencial de San Carlos, con una superficie total 5.889 KM2, según el siguiente detalle:

Cobquecura : 570 km2.
Coelemu : 342 km2.
Ninhue : 401 km2.
Ñiquén : 493 km2.
Quirihue : 589 km2.
San Carlos : 874 km2.
San Fabián : 1.568 km2.
San Nicolás : 491 km2.
Ránquil : 248 km2.
Trehuaco : 313 km2.

Población Comunal Asignada Red Hospital de San Carlos 2025
(todos los grupos etarios)

COMUNAS	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
San Carlos	27.566	29.656	57.222
San Fabián	2.352	2.471	4.823
San Nicolás	6.106	6.450	12.556
Ñiquén	5.705	5.807	11.512
Quirihue	5.969	6.275	12.244
Coelemu	8.264	8.642	16.906
Cobquecura	2.532	2.679	5.211
Ninhue	2.605	2.732	5.337
Trehuaco	2.847	2.932	5.779
Ránquil	3.068	3.226	6.294
TOTALES	**67.014**	**70.870**	**137.884**

Fuente: INE, CENSO 2017

5.1.- POBLACION OBJETIVO:

Para este proyecto, la población objetivo se situará dentro de una microrred conformada por las comunas más cercanas al Hospital de San Carlos como son; San Carlos, San Fabián, san Nicolás, Ñiquén y sectores rurales aledaños; específicamente abarcando un radio de 20 kilómetros a la redonda desde Hospital San Carlos como punto central.

Unidad de Proyectos e Inversiones – HSC
aldo.quiroz@redsalud.gov.cl Anexo Red MINSAL: 426260

El área de influencia es la provincia de Punilla, con las diferentes comunas:

- **Norte:** Hasta la comuna de San Gregorio centro y los siguientes sectores: Onihue, Ñiquen Estación, San Pedro de Ñiquen, las Miras, las Rosas, Tiuquilemu, Chacay, Buli, Buli oriente, Buli estación, Agua Buena, Gaona, Cape, entre otros.
- **Sur:** Hasta San Nicolás y Puente Ñuble (kilómetro 397 de Ruta 5 sur). Además de los siguientes sectores: Santa Josefina, San Miguel de Ablemo, San Pedro de Lilahue, Ninquihue, Santa Isabel, sector Chorrillos, La Primavera, Cocharcas, Huampangue, Huerto Bonito, El Manzano, Roble Viejo, Las Lomas, Dadinco, entre otros
- **Este:** Hasta la localidad de Cachapoal, Cachapoal alta, tres esquinas, Zemita y alrededores, San Fabian.
- **Oeste:** Hasta comuna de San Nicolás (urbano).

Así entonces, la población asignada a este proyecto es detallada de la siguiente forma:

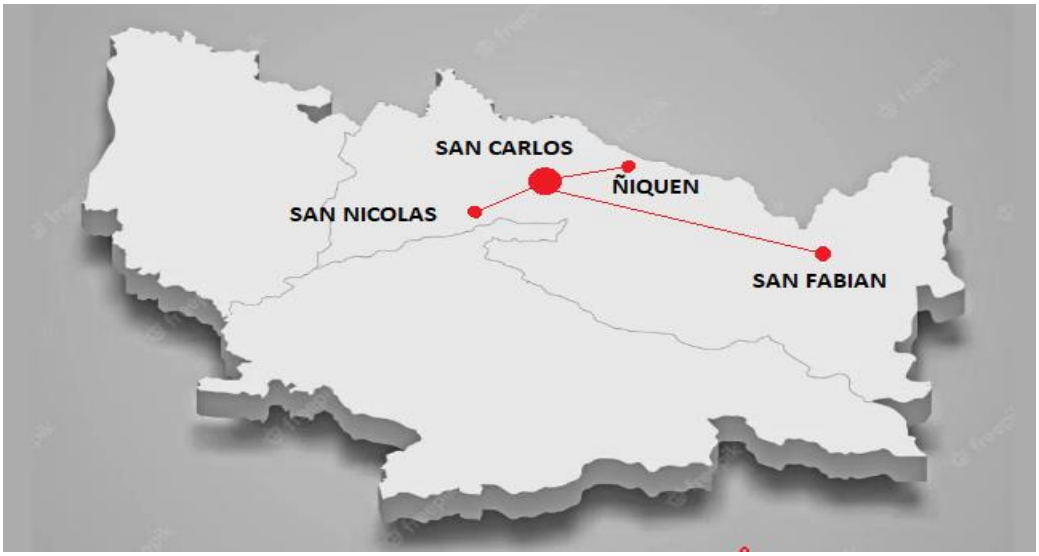
Población Objetivo HODOM

Hombres y mujeres mayores de 18 años

COMUNAS	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
San Carlos	20.979	23.296	**44.275**
San Fabián	1.817	1.929	**3.746**
San Nicolás	4.688	5.062	**9.750**
Ñiquén	4.565	4.698	**9.263**
TOTALES	**32.049**	**34.985**	**67.034**

Fuente: INE, CENSO 2017

COMUNAS BENEFICIARIAS HODOM SAN CARLOS



Unidad de Proyectos e Inversiones – HSC
aldo.quiroz@redsalud.gov.cl Anexo Red MINSAL: 426260

6.- ANALISIS DE LA OFERTA (Diagnóstico)

6.1.- OFERTA ACTUAL

Actualmente la oferta de Hospitalización Domiciliaria que se dispone en el establecimiento es a través de campaña de invierno y por compra de servicio. En esta modalidad se ha mantenido desde junio del año 2023 a la fecha. Con **una capacidad de 20/21 cupos con un promedio de 8 días de estada**. Los resultados de la gestión de este año son los siguientes: 2023,2024 y 2025.

COMPONENTES	**TOTAL 2023**
ALTAS	280
DIAS PERSONAS ATENDIDAS	4.037
FALLECIDOS – Esperados	13
FALLECIDOS – No esperados	0
INGRESOS	307
PERSONAS ATENDIDAS	307
REINGRESOS A HOSPITALIZACIÓN TRADICIONAL	16

Fuente: Unidad de Gestión de Pacientes y Movilización HSC

RRHH	**N° VISITAS POR ESTAMENTO 2023**
MEDICO	266
ENFERMERA	2.424
KINIESIOLOGO	1.466
FONOAUDIÓLOGA	544
TRABAJADORA SOCIAL	448
TOTAL	**5.148**

Fuente: Unidad de Gestión de Pacientes y Movilización HSC

COMPONENTES	**TOTAL 2024**
ALTAS	850
DIAS PERSONAS ATENDIDAS	6.508
FALLECIDOS – Esperados	16
FALLECIDOS – No esperados	0
INGRESOS	843
PERSONAS ATENDIDAS	1077
REINGRESOS A HOSPITALIZACIÓN TRADICIONAL	28

Fuente: Unidad de Gestión de Pacientes y Movilización HSC

RRHH	N° VISITAS POR ESTAMENTO 2024
MEDICO	1.280
ENFERMERA	4.688
KINIESIOLOGO	3.195
FONOAUDIÓLOGA	1.279
TRABAJADORA SOCIAL	1.120
TOTAL	**11.562**

Fuente: Unidad de Gestión de Pacientes y Movilización HSC

COMPONENTES	TOTAL 2025
ALTAS	629
DIAS PERSONAS ATENDIDAS	5.480
FALLECIDOS – Esperados	7
FALLECIDOS – No esperados	0
INGRESOS	598
PERSONAS ATENDIDAS	751
REINGRESOS A HOSPITALIZACIÓN TRADICIONAL	28

Fuente: Unidad de Gestión de Pacientes y Movilización HSC

RRHH	N° VISITAS POR ESTAMENTO 2025
MEDICO	1.390
ENFERMERA	3.184
KINIESIOLOGO	3.064
FONOAUDIÓLOGA	1.368
TRABAJADORA SOCIAL	0
TENS	422
TOTAL	**9.428**

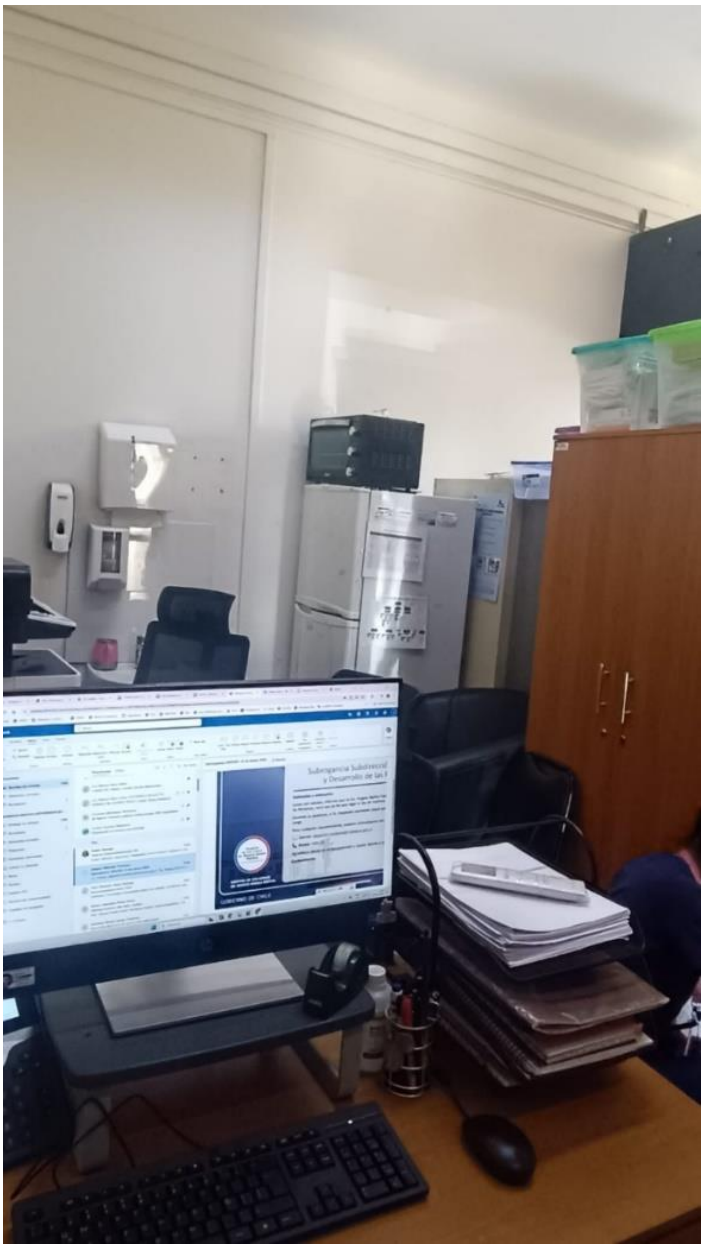
*El año 2025 dentro del Recurso Humano, no se contaba con Trabajadora Social.

6.2.- SITUACION ACTUAL DEL ESPACIO FISICO:

Desde que la Unidad de Hospitalización Domiciliaria se ha mantenido activa en el establecimiento, ha funcionado en distintos espacios físicos, rotando por diversas oficinas y dependencias del hospital.
A comienzos del año 2024, la unidad fue destinada de manera provisoria a un sector de la ex capilla, ubicada en el frontis del hospital.

En este espacio se concentran actualmente las áreas administrativas, el almacenamiento de insumos y el área de estar destinada al personal de la unidad. Sin embargo, las dimensiones del recinto, equivalentes a **5.130 m por 2.045 m**, junto con las condiciones físicas del lugar, resultan insuficientes para el adecuado desarrollo de las labores diarias. Esta situación obliga al personal a compartir un espacio reducido, lo que dificulta y afecta las condiciones generales de trabajo.

20
26



Unidad de Proyectos e Inversiones – HSC
aldo.quiroz@redsalud.gov.cl Anexo Red MINSAL: 426260

6.3. OFERTA PROYECTADA.

Este proyecto tiene el objetivo de implementar Hospitalización Domiciliaria de forma permanente en el Hospital de San Carlos. Para ello, se requerirá recurso humano especializado y equipamiento Clínico. Cabe mencionar que el hospital ya se dispone de las dependencias con las áreas establecidas en el DS N°1 artículo 19 título VII y de 3 móviles de transporte para atender las labores diarias.

La oferta proyectada se contempla en la atención de **20** a **25 pacientes por cada 7 días** como promedio días de estada, lo que se traduce en aproximadamente 75 pacientes al mes, y por tanto unos 900 pacientes al año. Esto se logrará optimizando y planificando un mejor flujo de acceso a las distintas rutas de las comunas beneficiarias, y optimizando la distribución del recurso humano en terreno.

7.- ANALISIS DE LA DEMANDA.

7.1.- PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO:

Para los próximos años, la población objetivo HSC proyectada para este proyecto es la siguiente:

Proyección Población mayores de 18 años

AÑO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
2023	32226	35.253	67.479
2024	32.401	35.521	67.922
2025	32.582	35.784	68.366
2026	32.763	36.055	68.818
2027	32.960	36.316	69.276

2028	33.138	36.570	69.708
2029	33.311	36.817	70.128
2030	33.455	37.029	70.484
2031	33.582	37.219	70.801
2032	33.709	37.410	71.119
2033	33.833	37.610	71.443
2034	33.938	37.790	71.728
2035	34.026	37.936	71.962
2036	34.281	38.273	72.554
2037	34.412	38.472	72.884

Fuente: INE, CENSO 2017

7.2.- PROYECCION DE LA DEMANDA.

7.2.1.- Cálculo de la Tasa.

Para el cálculo de la tasa, consideramos el total de producción HODOM año 2023.

(Año base/población año base)*1000

Año	2025
anual Usuarios atendidos 2025	629
Población Red Asistencial	67.034
Tasa	**9,67**

La tasa resultante para proyectar la demanda quirúrgica es de **9,67**. La proyección anual (648) se calculó considerando los usuarios atendidos dentro de los 5 meses de HODOM de este 2022 y convirtiéndolos a 12 meses de un año, logrando así los 648.

7.2.2.- Demanda Proyectada.

Se proyecta la población de manera que permita, de acuerdo al coeficiente elegido, obtener la proyección de demanda de intervenciones quirúrgicas en los próximos años.

(Tasa de consultas año 1 * población año 1) / 1000 hbtes.

(9,67 * 67.479)/1000 hbtes.

Proyección Demanda año 2026 – 2037

AÑO	POBLACION	DEMANDA PROYECTADA
2026	68.818	665
2027	69.276	670
2028	69.708	674
2029	70.128	678
2030	70.484	682
2031	70.801	685
2032	71.119	688
2033	71.443	691

2034	71.728	694
2035	71.962	696
2036	72.554	702
2037	72.884	705

Fuente: INE, CENSO 2017

8.- DEMANDA DE CAMAS.

La constante y sostenida demanda de camas en nuestro establecimiento ha impulsado con más fuerza la necesidad de implementar HODOM de manera permanente en nuestro establecimiento. Nuestro índice ocupacional de los principales servicios clínicos como cirugía, medicina y traumatología, ha provocado un número importante de hospitalizaciones en la unidad de urgencias a la espera que se desocupe una cama en los servicios mencionados.

A continuación, podrá visualizarse la gran cantidad de usuarios que quedaron hospitalizados en la Unidad de Urgencias particularmente en los años 2022 y 2023. Esta realidad se ha implantado en el establecimiento, sin posibilidad de mejorar si no se implementa una opción de atención que permita descongestionar los servicios clínicos más demandadas por nuestra población usuaria.

Oportunidad de Hospitalización en 12 hrs Adulto y Pediátrico						
Periodo	**Hospitalizado ≤ 12 hrs**	**Hospitalizado 12 hrs < x ≤ 24 hrs**	**Hospitalizado > 24 hrs**	**Permanece en UEH**	**Total**	**Cumplimiento**
2019	3.641	93	0	**18**	3.752	97,0%
2020	3.402	25	0	**0**	3.427	99,3%
2021	3.359	371	23	**9**	3.762	89,3%
2022	2.775	692	93	**337**	3.897	71,2%
2023	1.694	679	58	**218**	2.649	63,9%
2024	2.625	784	709	**337**	4.455	58,9 %
2025	2179	1.040	1.038	**372**	4.629	47,0%

Fuente: Departamento de la Información para la Gestión HSC

Oportunidad de Hospitalización en 12 hrs Adulto						
Periodo	**Hospitalizado ≤ 12 hrs**	**Hospitalizado 12 hrs < x ≤ 24 hrs**	**Hospitalizado > 24 hrs**	**Permanece en UEH**	**Total**	**Cumplimiento**
2019	3.234	89	0	**17**	3.340	96,8%
2020	3.185	23	0	**0**	3.208	99,3%
2021	3.150	370	23	**9**	3.552	88,7%
2022	2.450	663	93	**319**	3.525	69,5%
2023	1.427	647	57	**207**	2.338	61,0%

2024	2.176	759	700	**325**	3.960	54,9 %
2025	1.650	1.015	1.035	**368**	4.068	40,6 %

Fuente: Departamento de la Información para la Gestión HSC

8.1.- INDICE OCUPACIONAL ULTIMOS AÑOS.

Tal como lo mencionado anteriormente, el elevado índice ocupacional de los servicios de medicina, cirugía y traumatología han propiciado el alto número de hospitalizaciones generados en la unidad de urgencias.

INDICE OCUPACIONAL	2019	2022	2023	2024	2025
MEDICINA	**92,6**	**91,2**	**94,0**	**81,6**	97,5
UTI	72,2	83,4	74,7	93,8	83,0
CIRUGIA	**89,9**	**91,1**	**96,7**	**78,2**	96,0
AREA QUIRURGICA	--	4,5	80,9	93,4	98,1
TRAUMATOLOGIA	**93,0**	**92,8**	**95,9**	**82,9**	97,9
OBSTETRICIA	59,2	95,5	87,4	93,1	67,7
GINECOLOGIA	61,1	32,0	37,1	62,5	62,4
PEDIATRIA	10,3	36,7	51,8	42,9	70,3
NEONATOLOGIA	17,8	31,3	31,5	62,9	33,8
UCI	--	76,0	69,5	25,0	64,6
UHCIP	--	--	--	65,0	86,4
TOTAL	**77,4**	**79,9**	**81,9**	**81,6**	**86,6**

Fuente: Departamento de la Información para la Gestión HSC

9.- RECURSO HUMANO REQUERIDO.

A continuación, se detalla el recurso humano requerido para el adecuado funcionamiento de HODOM y que es el mismo que se ha dispuesto actualmente para el HODOM de campaña de invierno en nuestro establecimiento.

Con respecto a los usuarios que serán atendidos en HODOM con este RRHH, se incluyen pacientes con las siguientes patologías:

• Pielonefritis aguda.

• ITU multirresistente sin compromiso hemodinámico.

• NAC o Infecciones Respiratorias asociadas a atención de salud (IAAS) con o sin patología crónica, sin insuficiencia respiratoria aguda.

• Celulitis.

• Patologías crónicas descompensadas: EPOC, Asma, LCFA, ICC.

• Pacientes quirúrgicos intervenidos estables o con patología médica estable que requieren tratamientos endovenosos, curaciones avanzadas y/o atención kinésica y/o atención de fonoaudiólogo.

• Patologías Cerebrovasculares.
• Terapia anticoagulante para pacientes con TVP confirmada u otra patología que requiera ajuste de terapia anticoagulante.
• Rehabilitación neurológica.
• Rehabilitación motora y respiratoria.
• Rehabilitación deglutoria y/o del habla.
• Asistencia y asesoría con ayudas sociales desde CESFAM y/o I. Municipalidad local.

9.- DETALLE RECURSO HUMANO REQUERIDO.

N°	Jornada semanal	Gr.	Unit. Bruto	Total mensual	Total Anual
1	Médico General 44 hrs	-	$2.221.135	$2.221.135	$26.653.620
1	Médico General 22 hrs	.-	$1.110.568	$1.110.568	$13.326.810
1	Enfermera Coordinadora	12	$2.070.788	$2.070.788	$24.849.456
1	Trabajadora Social	15	$1.593.182	$1.593.182	$19.118.184
1	Fonoaudiólogo	15	$1.593.182	$1.593.182	$19.118.184
4	Conductores **(Cuarto turno modificado)**	24	$734.884	$2.939.536	$35.274.432
1	Conductor diurno	24	$563.574	$563.574	$6.762.888
1	Administrativo	22	$661.544	$661.544	$7.938.528
4	Enfermeros **(Cuarto turno modificado)**	15	$2.080.089	$8.320.356	$99.844.272
2	T.E.N.S. **(Cuarto turno modificado)**	21	$941.309	$1.882.618	$22.591.416
2	Kinesiólogos **(Cuarto turno modificado)**	15	$2.080.089	$4.160.178	$49.922.136
1	Kinesiólogo diurno	15	$1.593.182	$1.593.182	$19.118.184
			TOTAL	**$28.709.843**	**$344.518.110**

Fuente: Sub. de Gestión y Desarrollo de las Personas HSC - Se considera compra de servicios de traslados (solo vehículos)

(En sistemas de turno se considera una asignación de cuarto turno para el cálculo. El cual puede variar, debido que en este caso se cancelará según lo que supere las 44 hrs. Semanales.)

(*) Se necesita este enfermero para visita domiciliaria integral en conjunto con otros profesionales del equipo para optimizar los tiempos de los viajes. Durante esta visita se realizarán procedimientos tales como:
• Registro clínico de enfermería diaria.
• Plan de cuidados de Enfermería.
• Ejecución de procedimientos (instalación de vías venosas, instalación de sondas, toma de muestra de exámenes, toma de electrocardiogramas, administración de fármacos endovenosos, curaciones, etc.)
• Evaluación de intervenciones de enfermería.
• La educación a usuario y familiar o cuidador responsable sobre los cuidados del paciente.
• Coordinación con Unidades de apoyo del HSC y/o con la red.
• Control de signos vitales.

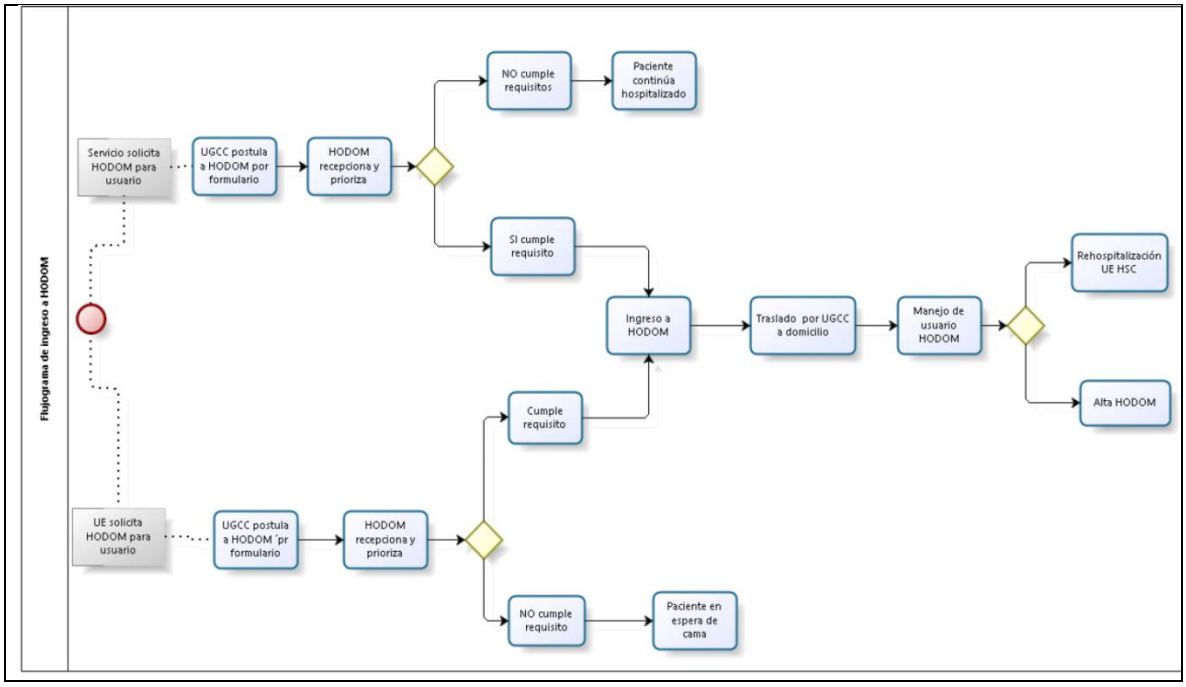
• Educación a paciente y/o familia: farmacoterapia, insulinoterapia, manejo de dispositivos invasivos (sonda Foley, sonda nasogástrica, Gastrostomía, traqueotomía, drenajes.), prevención de lesiones por presión, prevención de caídas, aseo y confort, movilización de paciente, etc.
• Instalación de Sonda Nasogástrica.
• Instalación de catéter urinario permanente.
• Instalación de catéter urinario intermitente.
• Tratamiento intramuscular, subcutáneo y endovenoso cada 12 horas.
• Instalación de vía subcutánea.
• Instalación de vía venosa periférica para administración de tratamientos endovenosos y/o fleboclisis.
• Toma exámenes sanguíneos venosos y arteriales.
• Toma de cultivos: urocultivo, hemocultivo, cultivo de herida.
• Curación simple.
• Curación avanzada de herida y manejo de ostomías.
• Contención emocional a pacientes LET y/o de paliativos y familia.
• Administración y manejo de nutrición parenteral.
• Reposo indicado y prevención de riesgos, según se establece en protocolos de prevención de caídas y de prevención de lesiones por presión (LPP).
• Cuidados de los accesos y dispositivos invasivos. Horarios de administración de medicamentos por vía oral.

9.2- SISTEMA DE COBERTURA HODOM.

N°	Profesional	Jornada semanal	Días de cobertura
1	Médico	Diurna – 44 horas	Lunes a viernes
1	Enfermera Coordinadora	Diurna – 44 horas	Lunes a viernes
1	Kinesiólogo diurno	Diurna – 44 horas	Lunes a viernes
1	Trabajadora Social	Diurna – 44 horas	Lunes a viernes
1	Fonoaudióloga	Diurna – 44 horas	Lunes a viernes
1	Conductor	Diurna – 44 horas	Lunes a viernes
4	Enfermeros clínicos	4 Enfermeros en cuarto turno modificado de 08:00 a 20:00 horas.	Largo – largo – libre – libre
2	T.E.N.S.	2 TENS en cuarto turno modificado de 08:00 a 20:00 horas.	Largo – largo – libre – libre
2	Kinesiólogos	2 Kinesiólogos en cuarto turno modificado de 08:00 a 20:00 horas.	Largo – largo – libre – libre
4	Conductores	4 Conductores en cuarto turno modificado de 08:00 a 20:00 horas.	Largo – largo – libre – libre

Fuente: Unidad de Gestión de Pacientes y Movilización HSC

10.- FLUJOGRAMA DE INGRESO A HODOM.



Fuente: Unidad de Gestión de Pacientes y Movilización HSC

11.- EQUIPOS MEDICOS REQUERIDOS.

Para implementar adecuadamente HODOM en nuestro establecimiento y de forma permanente, se necesita adquirir distinto equipamiento que sea exclusivo de HODOM HSC y no facilitados de otras áreas clínicas.

Cant.	Descripción	Costo Unit.	Costo Total
3	Oxímetros de pulso (Massimo Rad 5)	$2.790.000	$8.370.000
6	Maletines sanitarios	$218.000	$1.308.000
3	Equipos DEA	$1.839.000	$5.517.000
10	Colchones antiescaras con flotación de aire	$197.500	$1.975.000
4	Electro estimuladores	$890.000	$3.560.000
4	Pimómetros digitales	$4.462.500	$17.850.000
4	Computadores, pantalla de 27”	$749.990	$2.999.960
1	Impresoras láser multifuncionales dúplex.	$355.000	$355.000
2	Equipos celulares Smartphone	$450.000	$900.000
3	ECG portátil	$2.638.706	$7.916.118
3	Monitor multiparámetros	$2.970.000	$8.910.000
		TOTAL	**$59.661.078**

Fuente: Unidad de Proyectos e Inversiones HSC

Unidad de Proyectos e Inversiones – HSC
aldo.quiroz@redsalud.gov.cl Anexo Red MINSAL: 426260

12.- INFRAESTRUCTURA.

Respecto a la infraestructura requerida para el correcto funcionamiento de HODOM, se tiene contemplado un recinto que se encuentra al frente del establecimiento y que sería arrendado con cargo al subtitulo 22 del establecimiento. Esto es necesario ya que las actuales dependencias de HODOM son insuficientes para realizar las labores que se realizan actualmente y las que se esperan realizar a fututo considerando la demanda y las crecientes y sostenidas exigencias.

Estas dependencias destinadas para HODOM HSC contarían con todos los espacios adecuados para llevar a cabo debidamente la labor clínica diaria. Entre estos espacios se cuenta; sala área sucia y limpia, vestidores, estaciones de trabajo, bodega de insumos, oficina Enfermero coordinador y sala multiuso.

13.- VAC/CAE EQUIPOS CLINICOS.

Para los equipos solicitados en este proyecto, el VAC obtenido es de 89.952.342, y el CAE es de -12.221.641.-

	VAC	CAE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7.567.601	-8.021.658	50.135.360	-45.121.824									
2	18.008.750	-9.822.636	50.135.360	0	-36.097.459								
3	28.258.620	-10.571.827	50.135.360	0	4.010.829	-30.307.025							
4	37.834.146	-10.918.613	50.135.360	0	4.010.829	4.787.726	-25.111.556						
5	46.783.994	-11.106.352	50.135.360	0	4.010.829	4.787.726	4.969.660	-19.909.173					
6	55.153.375	-11.216.135	50.135.360	0	4.010.829	4.787.726	4.969.660	5.158.507	-14.699.614				
7	64.093.198	-11.481.336	50.135.360	0	4.010.829	4.787.726	4.969.660	5.158.507	5.354.530	-7.815.205			
8	72.510.525	-11.676.801	50.135.360	0	4.010.829	4.787.726	4.969.660	5.158.507	5.354.530	7.225.403	-2.527.103		
9	80.442.040	-11.826.769	50.135.360	0	4.010.829	4.787.726	4.969.660	5.158.507	5.354.530	7.225.403	7.499.968	2.771.431	
#	89.952.342	-12.221.641	50.135.360	0	4.010.829	4.787.726	4.969.660	5.158.507	5.354.530	7.225.403	7.499.968	7.784.967	11.717.15

Inversion Inicial	50.135.360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Costos de operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Costos de mantención	0	0	4.010.829	4.787.726	4.969.660	5.158.507	5.354.530	7.225.403	7.499.968	7.784.967	11.717.15
Costos operación + mantención	0	0	4.010.829	4.787.726	4.969.660	5.158.507	5.354.530	7.225.403	7.499.968	7.784.967	11.717.15
Valor Residual	5.013.536	45.121.824	40.108.288	35.094.752	30.081.216	25.067.680	20.054.144	15.040.608	10.027.072	5.013.536	

Fuente: Unidad de Proyectos e Inversiones HSC

14.- ALTERNATIVA ARRIENDO EQUIPOS.

La alternativa de arriendo de equipos es ineficiente económicamente, ya que lo que se termina pagando en muy superior al valor de compra. Prueba de ello es la licitación pública 1057501-407-LP25 donde, por ejemplo, se oferta un arriendo de monitores multiparámetros por un valor unitario de $ 102.900.- neto mensual. El valor de compra neto de un monitor multiparámetros es de $2.495.798.-. Por tanto, si multiplicamos esos $ 102.900 por 12 meses y por los 10 años de horizonte de evaluación, el resultado es $12.348.000, valor considerablemente mayor al precio de compra del equipo.

Si eso lo proyectamos, resulta lo siguiente:

Arriendo Monitor multiparámetros:

	VAC	CAE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.164.906	-1.234.800	0	1.234.800									
2	2.305.634	-1.257.578	0	1.234.800	1.281.722								
3	3.422.687	-1.280.461	0	1.234.800	1.281.722	1.330.428							
4	4.516.556	-1.303.440	0	1.234.800	1.281.722	1.330.428	1.380.984						
5	5.587.721	-1.326.505	0	1.234.800	1.281.722	1.330.428	1.380.984	1.433.462					
6	6.636.656	-1.349.648	0	1.234.800	1.281.722	1.330.428	1.380.984	1.433.462	1.487.933				
7	7.663.819	-1.372.858	0	1.234.800	1.281.722	1.330.428	1.380.984	1.433.462	1.487.933	1.544.474			
8	8.669.665	-1.396.128	0	1.234.800	1.281.722	1.330.428	1.380.984	1.433.462	1.487.933	1.544.474	1.603.165		
9	9.654.634	-1.419.446	0	1.234.800	1.281.722	1.330.428	1.380.984	1.433.462	1.487.933	1.544.474	1.603.165	1.664.085	
#	10.619.160	-1.442.804	0	1.234.800	1.281.722	1.330.428	1.380.984	1.433.462	1.487.933	1.544.474	1.603.165	1.664.085	1.727.32

Inversion Inicial	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Costos de operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Costos de ARRIENDO ANUAL	0	1.234.800	1.281.722	1.330.428	1.380.984	1.433.462	1.487.933	1.544.474	1.603.165	1.664.085	1.727.32
Costos operación + mantención	0	1.234.800	1.281.722	1.330.428	1.380.984	1.433.462	1.487.933	1.544.474	1.603.165	1.664.085	1.727.32
Valor Residual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Fuente: Unidad de Proyectos e Inversiones HSC

Compra monitor multiparámetros:

	VAC	CAE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	376.724	-399.328	2.495.798	-2.246.218									
2	896.497	-488.983	2.495.798	0	-1.796.975								
3	1.406.748	-526.278	2.495.798	0	199.664	-1.508.720							
4	1.883.429	-543.542	2.495.798	0	199.664	238.339	-1.250.083						
5	2.328.963	-552.888	2.495.798	0	199.664	238.339	247.396	-991.102					
6	2.745.601	-558.353	2.495.798	0	199.664	238.339	247.396	256.797	-731.764				
7	3.190.636	-571.555	2.495.798	0	199.664	238.339	247.396	256.797	266.555	-389.050			
8	3.609.661	-581.285	2.495.798	0	199.664	238.339	247.396	256.797	266.555	359.689	-125.802		
9	4.004.501	-588.751	2.495.798	0	199.664	238.339	247.396	256.797	266.555	359.689	373.357	137.965	
#	4.477.935	-608.408	2.495.798	0	199.664	238.339	247.396	256.797	266.555	359.689	373.357	387.545	583.29

Inversion Inicial	2.495.798	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Costos de operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Costos de mantención	0	0	199.664	238.339	247.396	256.797	266.555	359.689	373.357	387.545	583.29
Costos operación + mantención	0	0	199.664	238.339	247.396	256.797	266.555	359.689	373.357	387.545	583.29
Valor Residual	249.580	2.246.218	1.996.639	1.747.059	1.497.479	1.247.899	998.319	748.739	499.160	249.580	

Fuente: Unidad de Proyectos e Inversiones HSC

Unidad de Proyectos e Inversiones – HSC
aldo.quiroz@redsalud.gov.cl Anexo Red MINSAL: 426260

DESCRIPCIÓN	CAE
ALTERNATIVA DE ARRIENDO	**-1.442.804**
ALTERNATIVA DE COMPRA	**-608.408**

Por lo anterior, a la alternativa más viable económicamente es la de comprar los equipos requeridos y solicitados en este proyecto.

La mantención de los equipos que se adquieran, estará a cargo de la Sección Equipos Médicos del Hospital de San Carlos.

15.- CUADRO RESUMEN DE LO SOLICITADO.

DESCRIPCIÓN	SUBTITULO	COSTO TOTAL INVERSIONES	COSTO OPERACIONAL ANUAL
EQUIPOS MÉDICOS	**29**	$59.661.078	---
RECURSOS HUMANOS	**21**	---	$344.518.110
	TOTALES	**$59.661.078**	**$344.518.110**

Fuente: Unidad de Proyectos e Inversiones HSC

16.- ANÁLISIS FINAL DEL PROYECTO.

16.1.- Coherencia entre diagnóstico, objetivos y solución propuesta.

El proyecto presenta una alta coherencia técnica y estratégica entre:

- El diagnóstico institucional (sobredemanda, déficit estructural de camas, saturación de urgencias).
- Los objetivos planteados (optimización del recurso cama, continuidad asistencial, humanización de la atención).
- La solución propuesta, que es la implementación permanente de la Hospitalización Domiciliaria.

El diagnóstico se encuentra sólidamente respaldado por:

- Series históricas de índice ocupacional superiores al 90% en servicios críticos (medicina, cirugía, traumatología).
- Un deterioro progresivo de la oportunidad de hospitalización ≤12 horas, que cae desde cifras cercanas al 97% en 2019 a 47% en 2025, evidenciando un problema estructural y no coyuntural.

Esto demuestra que la presión asistencial no es transitoria, por lo que mantener HODOM solo como estrategia de campaña resulta insuficiente.

16.2.-. Pertinencia epidemiológica y territorial.

El proyecto se alinea de forma precisa con:

- El envejecimiento progresivo de la población de la provincia de Punilla.
- El aumento de patologías crónicas, respiratorias, infecciosas y neurológicas, todas altamente compatibles con manejo domiciliario.
- Una amplia ruralidad, que hace especialmente valiosa una estrategia de atención territorializada y flexible.

La delimitación clara de:

- Área de estudio (Región de Ñuble),
- Área de influencia (10 comunas de la red norte),
- Y población objetivo priorizada (≈67.000 adultos),

otorga robustez metodológica a las proyecciones de demanda y evita la sobreestimación de beneficios.

16.3.-. Evidencia empírica de efectividad del modelo HODOM.

Uno de los mayores puntos fuertes del proyecto es que no se trata de un modelo teórico, sino de una estrategia ya probada en el Hospital de San Carlos:

- Más de 2.100 personas atendidas entre 2023 y 2025.
- Cero fallecimientos no esperados en todos los períodos analizados.
- Bajísima tasa de reingreso a hospitalización tradicional (≈3–4%).
- Alto volumen de atenciones multidisciplinarias domiciliarias (hasta 11.562 visitas anuales).

Estos indicadores confirman que HODOM:

- Es segura,
- Es resolutiva,
- Y mantiene estándares clínicos equivalentes a la hospitalización cerrada.

16.4.-. Impacto en la gestión del recurso cama y la urgencia hospitalaria.

Desde una perspectiva de gestión sanitaria, la implementación permanente de HODOM:

- Libera camas de mediana complejidad para pacientes de mayor riesgo.
- Reduce hospitalizaciones prolongadas en Urgencia.
- Disminuye el riesgo de IAAS, delirium, deterioro funcional y descompensaciones asociadas a estancias largas.
-

Dado que el proyecto proyecta atender ≈900 pacientes al año, con una estada promedio de 7 días, se estaría liberando el equivalente a más de 6.000 días-cama anuales, lo que constituye un impacto estructural sobre la red hospitalaria local.

16.5.-. Análisis del recurso humano y sostenibilidad operativa.

El recurso humano propuesto:

- Es realista.
- Se basa en experiencia previa.
- Y está correctamente dimensionado según cobertura horaria y perfil de pacientes.

La estructura en cuarto turno modificado permite:

- Continuidad asistencial.
- Respuesta oportuna ante eventos intercurrentes.
- Optimización de rutas y tiempos de desplazamiento.

El costo anual estimado (~$345 millones) debe analizarse no solo como gasto, sino como inversión, considerando:

- Ahorro por días-cama evitados.
- Disminución de eventos adversos.
- Mejor desempeño en indicadores de gestión hospitalaria y satisfacción usuaria.

16.6.-. Alineación normativa y estratégica.

El proyecto cumple plenamente con:

- Decreto Supremo N°1 de Hospitalización Domiciliaria.
- Normativa de derechos y deberes del paciente.
- Lineamientos ministeriales de continuidad asistencial y gestión de la red.

Además, fortalece el rol del Hospital de San Carlos como nodo articulador entre el nivel secundario y la APS, consolidando un modelo moderno, integrado y centrado en las personas.

17.- CONCLUSIONES FINALES.

1.- La implementación permanente de la Hospitalización Domiciliaria en el Hospital de San Carlos es técnica, clínica y sanitariamente justificada, dada la presión estructural sobre el recurso cama y la urgencia hospitalaria.

2.- El proyecto demuestra que HODOM es una alternativa segura, eficaz y costo-efectiva, con resultados comprobados en años previos y con alto impacto en la calidad de la atención.

3.- La estrategia permite optimizar recursos hospitalarios sin sacrificar calidad, fortaleciendo la humanización del cuidado y la participación familiar.

4.- La evidencia presentada confirma que mantener HODOM solo como estrategia estacional limita su potencial, por lo que su consolidación permanente es una necesidad más que una opción.

5.- La implementación del proyecto contribuirá directamente a:

- Mejorar indicadores de oportunidad.
- Reducir hospitalizaciones evitables.
- Fortalecer la red asistencial norte de Ñuble.
- Aumentar la satisfacción usuaria y del equipo clínico.

6.- En conclusión, este proyecto no solo responde a una brecha actual, sino que se anticipa al crecimiento futuro de la demanda, constituyéndose en una política sanitaria local sostenible y alineada con el modelo de salud integral promovido por el MINSAL.

Unidad de Proyectos e Inversiones – HSC
aldo.quiroz@redsalud.gov.cl Anexo Red MINSAL: 426260